CÁNCER DE ESTÓMAGO

DRA. STEPHANY TORRES

EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO

- Más frecuente en hombres y después de los 50 años; alta incidencia en Asia y América Latina.
- Factores de riesgo: infección por H. pylori, dieta rica en ahumados y salados, tabaquismo, gastritis atófica y antecedentes familiares.

CLASIFICACIÓN

- Lauren: tipo intestinal (bien diferenciado, asociado a H. pylori) y tipo difuso (células en anillo de sello, peor pronóstico, más en jóvenes).



LAUREN: TIPO INTESTINAL

- Ancianos (>75 años); bien/moderadamente diferenciado, glandular; epidémico; H. pylori, gastritis atrófica, metaplasia y nitratos; diseminación hematógena; cascada de Correa.

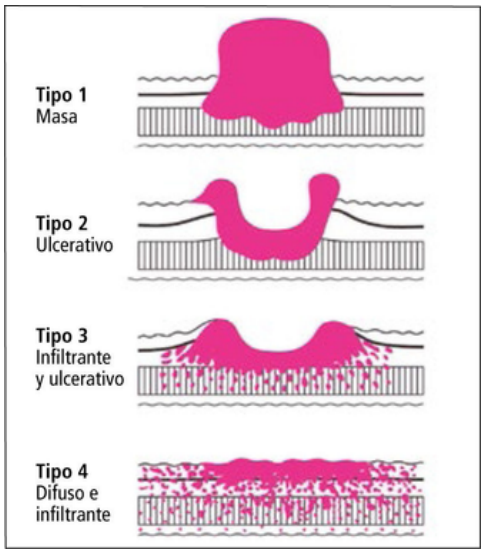
LAUREN: TIPO DIFUSO

- Jóvenes (<35 años en hasta 70%); pobremente diferenciado; endémico; CDH1 (E-cadherina); linitis plástica, diseminación transcelómica y ganglionar precoz; células en anillo de sello.

BORRMAN

- Borrmann (según el aspecto macroscópico): polipoide, ulcerado, ulcerado-infiltrante o infiltrante difuso (linitis plástica).

- Temprano: limitado a mucosa/submucosa. Avanzado: invade la muscular propia o más allá.



SEGUIMIENTO Y PRONÓSTICO

- La supervivencia depende sobre todo del estadio al diagnóstico y la profundidad de invasión.
- El cáncer gástrico temprano tratado a tiempo tiene supervivencia a 5 años mayor al 90%.
- Seguimiento con endoscopia e imágenes periódicas para detectar recurrencia.

DIAGNÓSTICO

- Endoscopia con biopsia: es el estándar de oro.
- Estadificación: TC de abdomen y pelvis; en casos seleccionados, ecoendoscopia o laparoscopia diagnóstica.
- Síntomas de alarma: pérdida de peso, disfagia, saciedad temprana y sangrado digestivo.

TRATAMIENTO

- Gastrectomía subtotal (tumores distales) o total (tumores proximales o difusos), con linfadenectomía D2.
- Quimioterapia perioperatoria en tumores localmente avanzados.
- El margen quirúrgico negativo y una linfadenectomía adecuada son los principales factores pronósticos modificables.

CÁNCER DE ESTÓMAGO

DRA. STEPHANY TORRES

CDH1 Y TAMIZAJE DUAL

- Riesgo de cáncer difuso hereditario >70–80% y asociación con cáncer lobulillar de mama: endoscopías con biopsias (o gastrectomía profiláctica) y RM mamaria anual desde los 30 años.

FACTORES OCUPACIONALES

- Minería con exposición a molibdeno (cinturón andino, Chile); pesticidas organoclorados y conservantes nitrogenados.

CÁNCER DEL MUÑÓN GÁSTRICO

- Tras Billroth I/II: el reflujo alcalino biliopancreático causa gastritis, atrofia, metaplasia y neoplasia 20–30 años después.

CÁNCER GÁSTRICO ASOCIADO A EBV

- ~13%; proximal y en varones; fenotipo metilador (CIMP-high) que silencia supresores (P53); estroma linfoide denso con buena respuesta a la inmunoterapia.

TABACO Y H. PYLORI

- Sinergia: tabaquismo + cepas CagA/VacA eleva el RR de cáncer distal hasta 16.

H. PYLORI EN LATINOAMÉRICA

- Prevalencia >80% en adultos; presente en 76–80% de los cánceres gástricos, pero <1% de los infectados desarrolla cáncer: necesario pero insuficiente.

TUMORES DE CARDIAS

- Difuso, jóvenes; tabaco, alcohol, obesidad central y reflujo; CDH1.

TUMORES NO CARDIAS

- Intestinal, >70–75 años; H. pylori y nitratos; grupo sanguíneo A (+20%) y enfermedad de Ménétrier.

CASCADA DE CORREA

- Mucosa normal → gastritis crónica → atrofia → metaplasia intestinal → displasia → carcinoma invasivo.
- Metaplasia: erradicar H. pylori y vigilar; displasia de alto grado: resección endoscópica (REM/DSE) o quirúrgica.

